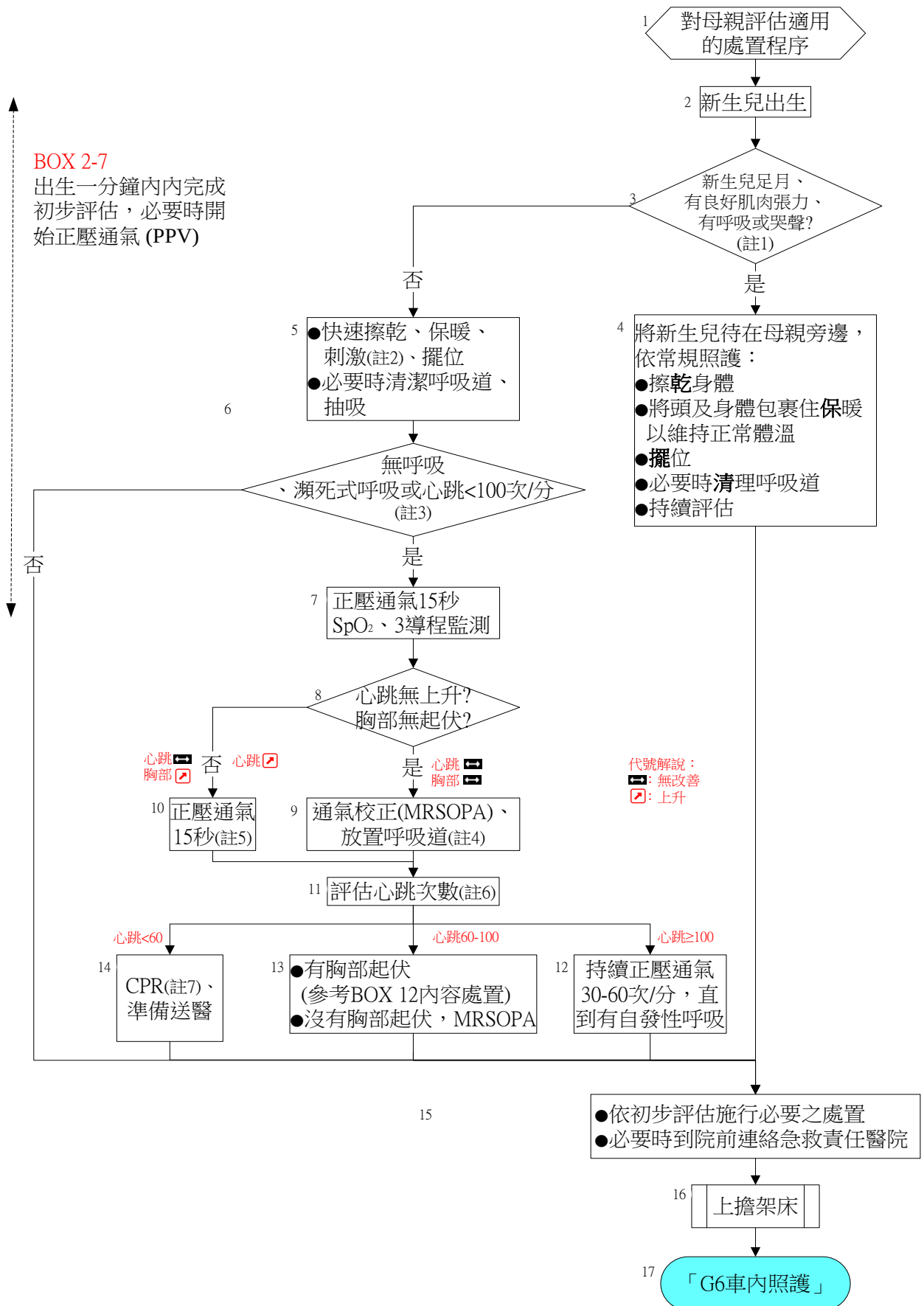


S7 新生兒

程 序

BOX 2-7

出生一分鐘內內完成
初步評估，必要時開
始正壓通氣 (PPV)



要 旨

- 一、現場或送醫途中經緊急接生、自然娩出之新生兒或新生兒第一次住院期間適用本程序，新生兒返家後之急救適用嬰兒之步驟（兒童高級救命術PALS流程）。
- 二、新生兒 CPR 之方式為 3:1、速率是每分鐘總共 90 下按壓及 30 下通氣。

註 解

註1>

- 一、正常新生兒是指足月，有呼吸或哭聲且有良好肌肉張力的新生兒。
- 二、Apgar score(若有計算Apgar score時，以第1分鐘及第5分鐘記錄於救護紀錄表)。

評分項目	0	1	2
膚色	全身呈現缺氧的灰色或藍色	四肢發紺	全身通紅、軀幹紅色
心跳	無	<100次/分	≥100次/分
反射	抽取口鼻的羊水時，完全沒有反應	抽取口鼻的羊水時，只有臉部有反應	抽取口鼻的羊水時，有活力的哭鬧
肌肉張力	無	只有軟弱的彎曲	四肢有很好的活動力
呼吸	無	呼吸微弱或哭聲微弱	很好，有宏亮哭聲

- 三、若新生兒需要進行CPR急救時，應給予100% O₂。

註2>

刺激：可考慮戳背或輕彈新生兒的腳

註3>

新生兒正常心跳至少≥100次/分。新生兒心跳<100次/分、沒有正常呼吸時，先給予通氣15秒。

註4>

通氣15秒過程，發現心跳沒有上升且胸部沒有起伏時，進行通氣校正(MRSOPA)：

M：面罩(Mask adjustment)，面罩是否適合、漏氣，必要時雙人通氣。

R：擺位(Reposition head)，調整新生兒頭部位置使呼吸道保持通暢或頸部墊肩。

S：抽吸(Suction mouth and nose)，檢查是否需要抽吸(先口再鼻)。

O：暢通(Open mouth)，確保口部開啟，可抬下頷。

P：加壓(Pressure increase)通氣，增加通氣壓力直到有胸部起伏。

A：替代呼吸道(Alternative airway)，放置SGA。

目標血飽和度表	
2分鐘	65-70%
3分鐘	70-75%
4分鐘	75-80%
5分鐘	80-85%
10分鐘	85%-95%

註5>

通氣15秒過程，發現下列其中1項時，繼續通氣15秒。

- 一、心跳有上升。
- 二、心跳沒有上升但胸部有起伏。

註6>

一、有效通氣30秒後評估每分鐘心跳次數：

- (一) 心跳<60次/分：進行CPR，並考慮準備送醫。
- (二) 心跳60-100次/分：有胸部起伏時，持續正壓通氣(30-60次/分)；沒有胸部起伏時進行MRSOPA。
- (三) 持續持續正壓通氣40-60次/分，直到有自發性呼吸。

二、若無法立即離開(如高救隊進行其他處置)時，每1分鐘重新評估心跳次數。

註7>

新生兒心肺復甦術（出生到第1次住院期間）

- 一、以目視方式用兩手環抱嬰兒胸部，兩拇指併攏按壓按壓兩乳頭連線中點正下方的胸骨處。

- 二、下壓深度約胸壁厚度的1/3，每次按壓後手指不離開胸部，但必須放鬆讓胸部回彈，壓與放的時間各約佔50%。
- 三、胸部按壓與BVM人工呼吸(氧氣)之比例為3：1。速率是每分鐘總共 90 下按壓及 30 下通氣。
- 四、CPR約60秒後，在通氣之同時應檢查心跳（評估時間不超過10秒），並依程序BOX 11進行後續處置或準備送醫。